

약제 요양급여의 적정성 평가결과

ocrelizumab 300mg

(오크레부스주(오크렐리주맙), (주)한국로슈)

☐ **제형, 성분함량:**

- 1병(10mL) 중 ocrelizumab 300mg

☐ **효능·효과**

1. 임상적 독립증후군, 재발 완화형 다발성 경화증 및 활성 이차 진행형 다발성 경화증을 포함한 성인의 재발형 다발성 경화증(RMS, relapsing forms of multiple sclerosis)의 치료
2. 성인의 일차 진행형 다발성 경화증(PPMS, primary progressive multiple sclerosis)의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2024년 제11차 약제급여평가위원회: 2024년 11월 7일

- 약제 급여기준 소위원회 심의일: 2024년 7월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “임상적 독립증후군, 재발 완화형 다발성 경화증 및 활성 이차 진행형 다발성 경화증을 포함한 성인의 재발형 다발성 경화증(RMS, relapsing forms of multiple sclerosis)의 치료” 및 “성인의 일차 진행형 다발성 경화증(PPMS, primary progressive multiple sclerosis)의 치료”에 허가받은 약제로,
 - “임상적 독립증후군, 재발 완화형 다발성 경화증 및 활성 이차 진행형 다발성 경화증을 포함한 성인의 재발형 다발성 경화증(RMS, relapsing forms of multiple sclerosis)의 치료”에 대해 대체약제와 효과가 유사하나, 투약비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■ 원/병) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■%, ■ 원/병) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.
 - “성인의 일차 진행형 다발성 경화증(PPMS, primary progressive multiple sclerosis)의 치료”에서 위약 대비 장애진행 비율 등에서 임상적 유용성 개선이 인정되나, 비용효과성이 불분명하므로 약값 전액을 본인 부담함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “① 임상적 독립증후군, 재발 완화형 다발성 경화증 및 활성 이차 진행형 다발성 경화증을 포함한 성인의 재발형 다발성 경화증(RMS, relapsing forms of multiple sclerosis)의 치료, ② 성인의 일차 진행형 다발성 경화증(PPMS, primary progressive multiple sclerosis)의 치료”에 허가 받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장 여부 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “① 성인의 재발형 다발경화증(RMS, relapsing forms of multiple sclerosis)” 및 “② 성인의 일차 진행형 다발경화증(PPMS, primary progressive multiple sclerosis)”에 허가된 약제로 B세포의 CD20에 대한 인간화 단클론 항체로써 CD20을 발현하는 B세포 수의 감소를 통해 다발경화증 환자의 면역 조절을 일으키며, 다발경화증의 질병조절치료제(DMT; disease modifying therapy) 중 하나임.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 재발형 다발경화증(RMS)의 질병조절치료(DMT; disease

modifying therapy) 약제 중 하나로 언급되며 일차 진행형 다발경화증(PPMS) 및 이차 진행형 다발경화증(SPMS)에 허가된 약제로 소개되고 있음. 가이드라인⁴⁵⁾에서는 RMS, PPMS, SPMS에 권고됨.

- (ECTRIMS/EAN Guideline, 2018) 활성(active) RRMS에서 신청품을 포함한 DMT의 빠른 투여가 권고됨[strong]. 약제는 환자의 특성과 질병의 활성도를 고려하여 선택하도록 권고함. RMS에서 Interferon 또는 glatiramer acetate 투여 후 질병이 진행된 경우 신청품을 포함한 더 효과적인 약제 투여가 권고됨[strong]. 활성(active) SPMS와 PPMS에서 신청품을 권고함[weak].
- (AAN, 2018) RMS에서 DMT 투여 권고함[Level B]. PPMS에게 (치료의 이익이 위험을 상회하는 경우) 신청품을 투여하도록 권고함[Level B].

① 재발형 다발경화증(RMS)

- [OPERA I/II, 활성약 대조 3상]⁶⁾ McDonald criteria(2010)에 따라 진단된 18-55세 사이의 다발경화증 환자를 대상⁷⁾으로 신청품(ocrelizumab 600mg), 대조군(interferon β -1a)으로 1:1 무작위 배정하여 96주 동안 유효성 및 안전성을 평가한 다국가, 다기관, 활성 대조, 3상 연구 결과,
 - 해당 결과는 동일한 protocol의 OPERA I, OPERA II 임상연구 결과임⁸⁾.
 - 1차 유효성 평가변수는 96주차의 연간재발률(ARR: annualized relapse rate)로 OPERA I 과 II에서 신청품이 대조군보다 낮은 재발률을 보였음.
 - ✓ [OPERA I] 신청품군 vs. 대조군(0.16 vs. 0.29, rate ratio 0.54; 95% CI 0.40 to 0.72, $p < 0.001$)
 - ✓ [OPERA II] 신청품군 vs. 대조군(0.16 vs. 0.29, rate ratio 0.53; 95% CI 0.40 to 0.71, $p < 0.001$)
 - 2차 유효성 평가변수인 12주 확인된 장애 진행⁹⁾ 환자 비율은 pooled 결과에서 신청품군 9.1%, 대조군 13.6%로 신청품이 더 낮았으며(HR 0.60; 95% CI 0.45 to 0.81, $p < 0.001$), 24주 확인된 장애 진행 환자 비율의 pooled 결과도 신청품군 6.9%, 대조군 10.5%로 신청품군이 더 낮았음(HR 0.60; 95% CI 0.43 to 0.84, $p = 0.003$).
 - 그 외 2차 유효성 평가변수인 12주 확인된 질병 개선 환자 비율, MSFC 점수 변화, PRO 지표는 신청품이 대조군보다 높았으나 OPERA I/II 모두에서 유의성을 보이지는 못했음. MRI 관련 3가지 지표 모두에서는 신청품이 대조군보다 MRI 스캔 당 측정되는 병변 개수가 유의하게 적었음.
 - (안전성) 이상반응은 OPERA I에서 신청품군 80.1%, 대조군 80.9%, OPERA II에서 신청품군 86.3%, 대조군 85.6%에서 발생했으며 가장 흔한 이상 반응은 주입 관련 반응(Infusion-related reaction), 비인두염, 상기도 감염 등 이었음. 이상반응으로 치료를 중단한 환자는 OPERA I에서 신청품군 3.2%, 대조군 6.4%, OPERA II에서 신청품군 3.8%, 대조군 6.0%였음.

- ✓ 심각한 이상 반응(SAEs; serious adverse events)은 OPERA I에서 신청품군 6.9%, 대조군 7.8%, OPERA II에서 신청품군 7.0%, 대조군 9.6% 발생하였음.
 - ✓ 전체 감염 발생 비율은 OPERA I에서 신청품군 56.9%, 대조군 54.3%, OPERA II에서 신청품군 60.2%, 대조군 52.2% 발생하였으며, 심각한 감염 및 감염증의 경우 OPERA I에서 신청품군 1.2%(5/408), 대조군 2.9%(12/409), OPERA II에서 신청품군 1.4%(6/417), 대조군 2.9%(12/417) 발생하였음.
 - ✓ 신생물(neoplasm)은 OPERA I에서 신청품군 0.7%(3/408), 대조군 0.2%(1/409), OPERA II에서 신청품군 0.2%(1/417), 대조군 0.2%(1/417) 발생하였고, 사망은 OPERA I/II에서 신청품군 1명, 대조군에서 2명 발생했으며 신청품군과 대조군 1명의 사망원인은 자살, 대조군 1명은 장폐색으로 인하여 발생하였음.
- [OPERA I/II, 3년 추가 연장]¹⁰⁾ OPERA I/II의 double-blind phase(2년) 이후, 대조군의 교체 투여를 허용하여 open-label으로 추가 3년간(총 5년) 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 결과,
- 연간재발률(ARR)은 신청품군(n=702)과 교체투여군(n=623) 교체 투여후 1년차 0.1 vs 0.1(p=0.8), 2년차 0.08 vs. 0.08(p=0.97), 3년차 0.07 vs. 0.065(p=0.7)로 교체 투여 후에는 각 군이 유의한 차이를 보이지 않았음.
 - ✓ 대조군은 교체 투여후 1년차에 직전년도와 비교하여 재발률이 52% 감소하였음. (0.20 vs. 0.10, adj. rate ratio 2.069; 95% CI 1.547 to 2.766, p<0.001).
 - 24주 확인된 장애 진행 환자 비율(24-week CDP; Disability progression confirmed at 24wk)은 교체 투여후 3년차에 신청품군 16.1%, 교체투여군 21.3%으로 신청품군이 낮았음.(difference 5.20%; 95% CI 1.05 to 9.35; p=0.014)
 - ✓ 연장연구 시작 시점에(OLE baseline) 기저치를 보정하면 연장연구 기간의 신청품군과 교체투여군의 장애 진행 발생 위험도에 유의한 차이가 없었음(HR 1.06; 95% CI 0.8 to 1.41, p=0.7).
 - 24주 확인된 장애 개선 환자 비율(24-week CDI; 24-week confirmed disability improvement)은 교체 투여후 3년차에 신청품군 25.8%, 교체투여군 20.6%으로 신청품군이 높았음.(p=0.046).
 - ✓ 연장연구 시작 시점에(OLE baseline) 기저치를 보정하면 연장연구 기간의 신청품군과 교체투여군의 장애 개선 발생 위험도에 유의한 차이가 없었음(HR 0.89; 95% CI 0.61 to 1.31, p = 0.6)
 - (안전성) 이상반응 발생률은 220(100인년당)으로 OPERA 임상에서 각군의 발생률 보다(신청품 290, 대조군 296) 낮았으며, 가장 흔한 이상 반응은 주입 관련 반응(Infusion-related reaction), 요로 감염, 상기도 감염 등 이었음.
 - ✓ 심각한 이상 반응(SAEs; serious adverse events) 발생률은 6.1으로 기존

OPERA double blind phase에서의 발생률인 신청품군 5.39, 대조군: 6.29과 유사하였음.

- ✓ 전체 감염 발생률은 75.3으로 OPERA double blind phase에서 관찰된 비율과 유사하였고, 가장 흔한 심각한 감염 및 감염증은 요로 감염, 폐렴이었으며, PML은 보고되지 않음.
- ✓ 악성종양(malignancy) 발생률은 0.4였으며, OPERA double blind phase에서 각 군의 발생률은 신청품군 0.28, 대조군 0.14 었음.

- [네트워크 메타분석]¹¹⁾ 재발형 다발경화증(RMS)에 사용되는 질병조절제(DMT: disease modifying therapies)의 효과 및 안전성을 비교하기 위해, RMS 대상으로 최소 12주 이상의 기간동안 관찰한 무작위 대조 임상시험 33개를 선정하여 신청품과 질병조절제의 효과 및 안전성에 대한 메타분석을 수행한 결과,

- (유효성 평가) 12주 확인된 장애 진행 위험(12-week CDP; 12-week confirmed disability progression), 연간재발률(ARR; annualized relapse rate)을 평가하였음.
 - ✓ 12-week CDP는 alemtuzumab (HR 0.92; 95% CI 0.58, 1.46), cladribine 3.5mg/kg (HR 0.58; 95% CI 0.32, 1.04), natalizumab (HR 0.67; 95% CI 0.38, 1.18), fingolimod (HR 0.53; 95% CI 0.32, 0.88)로 fingolimod를 제외하고 신청품과 대체로 유사한 효과를 보였음.
 - ✓ 연간재발률(ARR)은 alemtuzumab (rate ratio 1.19; 95% CI 0.94, 1.53), cladribine 3.5mg/kg (rate ratio 0.80; 95% CI 0.55, 1.13), natalizumab (rate ratio 1.07; 95% CI 0.77, 1.46), fingolimod (rate ratio 0.73; 95% CI 0.54, 0.96)로 fingolimod를 제외하고 신청품과 대체로 유사한 효과를 보였음.
- (안전성) 심각한 부작용(SAEs; serious adverse events) 발생률과 부작용으로 인한 중단 비율을 평가하였으며, 신청품과 alemtuzumab, cladribine 3.5mg/kg, natalizumab, fingolimod의 이상 반응 발생은 차이 없었음.

② 일차 진행형 다발경화증(PPMS)

- [ORATORIO, 위약 대조 3상]¹²⁾ McDonald criteria(2005)에 따라 진단된 18-55세 사이의 일차 진행형 다발경화증 환자¹³⁾에서 신청품(ocrelizumab 600mg)과 위약군으로 2:1 무작위 배정한 후, 최소 120주 이상 투여한 환자를 대상으로 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 다국가, 다기관, 평행 그룹, 위약 대조, 3상 연구 결과,
 - 1차 유효성 평가변수인 12주 확인된 장애 진행¹⁴⁾ 환자 비율은 신청품군 32.9%(160/487), 위약군 39.3%(96/244)로 신청품군이 더 낮았음(HR 0.76; 95% CI 0.59 to 0.98, p=0.03).
 - 2차 유효성 평가 변수인 24주 확인된 장애 진행 환자 비율은 신청품군 29.6%(144/487), 위약군 35.7%(87/244)로 신청품군이 더 낮았음(HR 0.75; 95% CI 0.58 to 0.98, p=0.04).

- 그 외 2차 유효성 평가변수 결과는 아래와 같음. 25피트를 걷는데 걸린 시간(timed 25ft walk) 평균 변화율은 신청품군이 위약군보다 더 적게 변화하였고, MRI 관련 지표인 T2 가중 MRI 영상의 고신호 병변 총 부피는 신청품군에서는 기저 대비 감소하였으나, 위약군에서는 증가하였고 24주차에서 120주차 사이의 뇌 부피의 평균 변화율은 신청품군이 위약군보다 낮았음.
- (안전성) 이상반응은 신청품군 95.1%, 위약군 90.0%에서 발생하여 양군에서 비슷하게 발생하였고, 가장 흔한 이상 반응은 주입 관련 반응(Infusion-related reaction), 비인두염, 상기도 감염 등 이었음. 이상반응으로 치료를 중단한 환자는 신청품군 4.1%(20/486), 위약군 3.3%(8/239)이었음.
 - ✓ 심각한 이상 반응(SAEs; serious adverse events)은 신청품군 20.4%(99/486), 위약군 22.2%(53/239)에서 발생하였음.
 - ✓ 심각한 감염(serious infection) 발생 비율은 신청품군 6.2%(30/486), 위약군 5.9%(14/239)에서 발생하였음.
 - ✓ 신생물(neoplasm)은 신청품군 2.3%(11/486), 위약군 0.8%(2/239), 사망은 신청품군 4명, 위약군에서 1명 발생했으며 신청품군의 사망원인은 폐색전증, 폐렴, 췌장암, 흡인성 폐렴이며, 위약군 1명은 교통사고였음.
- [ORATORIO, 추가 연장]¹⁵⁾ ORATORIO의 double-blind phase 이후, 위약군의 교체투여를 허용하여 open-label로 추가 3.5년간(총 6.5년)¹⁶⁾ 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 결과,
 - EDSS 단계 변화, 9-Hole Peg Test(9HPT), Timed 25-Foot Walk(T25FW) 기준으로, 24주 확인된 장애 진행을 평가하였으며, 모든 측정 기준으로 신청품군(n=367)이 교체투여군(n=160) 보다 장애 진행 환자 비율이 낮았음¹⁷⁾.
 - ✓ EDSS 점수 기준: HR 0.72 (95% CI 0.58 to 0.89, p=0.0021)
 - ✓ 9HPT 기준: HR 0.65 (95% CI 0.50 to 0.86, p=0.002)
 - ✓ T25FW 기준: HR 0.77 (95% CI 0.64 to 0.94, p=0.0101)
 - (안전성) 전체 기간의 이상반응 발생률은 238.09(100인년당)으로 기존 ORATORIO 각군 발생률보다(신청품 252.09, 위약군 258.88) 낮았으며, 가장 흔한 이상 반응은 주입 관련 반응(Infusion-related reaction)이었음.
 - ✓ 심각한 이상 반응(SAEs; serious adverse events) 발생률은 12.63이며, 기존 ORATORIO double blind phase에서의 발생률은 신청품군 10.15, 위약군 12.07이었음.
 - ✓ 전체 감염 발생률은 73.16으로 ORATORIO double blind phase에서 관찰된 비율(신청품: 70.8, 위약군: 72.5)과 유사하였고, 가장 흔한 심각한 감염 및 감염증은 요로 감염, 폐렴, 봉소염이었으며, PML은 보고되지 않음.

- 관련 학회¹⁸⁾에서는 신청품은 재발형 다발경화증(RMS)에 허가된 고효능 약제로 임상시험에서 다발경화증에 장기적인 효과와 안전성을 보였으며, 현재 2차 치료제(alemtuzumab, cladribine, natalizumab, fingolimod) 투여 후 재발되거나 약제별 부작용으로 장기간 사용할 수 없는 환자들에게 추가적인 치료 옵션으로 급여 적용이 필요하다는 의견임. 또한, 신청품은 일차 진행형 다발경화증(PPMS)에 효과를 입증한 유일한 약제이므로 급여가 필요하다는 의견임.

○ 비용 효과성

① 재발형 다발경화증(RMS)

- 신청품의 급여기준(안), 교과서, 임상진료지침, 임상연구 및 학회의견 등을 고려하여 alemtuzumab, cladribine, natalizumab, fingolimod을 대체약제로 선정함.
- 신청품의 소요비용(■■■■ 원/2년)은 대체약제 가중평균가(■■■■ 원/2년) 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■ 원/병이며, 약가협상 생략기준금액¹⁹⁾은 ■■■■ 원/병임.

② 일차 진행형 다발경화증(PPMS)

- 신청품은 교과서 및 가이드라인에서 PPMS에 허가된 유일한 약제로 소개되며, 현재 PPMS에 허가 및 급여되는 약제는 없음.
- 신청품의 연간 소요비용은 ■■■■ 원/1년임.

○ 재정 영향²⁰⁾

① 재발형 다발경화증(RMS)

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²²⁾은 1차년도 약 ■■■■ 원, 3차년도 약 ■■■■ 원이고, 대체약제의 대체로 인해 재정소요금액이 1차년도에 약 ■■■■ 원, 3차년도에 약 ■■■■ 원 증가할 것으로 예상됨.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도에 약 ■■■■ 원, 3차년도에 약 ■■■■ 원이 되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

② 일차 진행형 다발경화증(PPMS)

- 제약사 제출 예상사용량²⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁵⁾은 1차년도 약 ■■■■ 원, 3차년도 약 ■■■■ 원임.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여횟수 및 기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 6개국 약가집(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스)에 수재되어 있음.

References

- 1) 신경학 4판(대한신경과학회, 2024) > 15장. 다발경화증 및 탈수초질환
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e(2023) > Chapter 444: Multiple Sclerosis
- 3) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e(2023)> Chapter 39: Immunosuppressants, Immunomodulation, and Tolerance.
- 4)ECTRIMS/EAN(European Committee of Treatment of Research in Multiple Sclerosis/European Academy of Neurology) Guideline on the pharmacological treatment of people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2018, Vol. 24(2) 96 - 120.
- 5) Practice guideline recommendations summary: Disease-modifying therapies for adults with multiple sclerosis Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2018;90:777-788.
- 6) S.L. Hauser, et al. Ocrelizumab versus Interferon Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis. N Engl J Med 2017;376:221-34.
- 7) 포함 조건: EDSS 단계가 0-5.5인 환자, 지난 2년간 적어도 2번의 재발이 있었거나 스크리닝 전 1년간 적어도 한 번의 재발이 있던 환자, MRI로 확인되는 뇌 이상이 있는 환자, 최근 30일 이내에 신경학적 악화가 없던 환자.
- 8) 각 임상의 환자수(ITT 기준)

비교	환자수(ITT 기준)		등록 기관
	신청품군(n)	대조군(n)	
OPERA I	410명	411명	32개국, 141개 기관
OPERA II	417명	418명	24개국, 166개 기관

- 9) 장애 진행(disability progression): 최소 12주 또는 24주 이상 기저치 EDSS 단계보다 1단계 이상 낮아진 경우를 뜻함. 단, 기저 EDSS 단계가 5.5 보다 큰 경우는 기저치 대비 0.5 단계 이상 낮아진 경우를 뜻함.
- 10) Stephen L. Hauser, et al. Five years of ocrelizumab in relapsing multiple sclerosis: OPERA studies open-label extension. Neurology 2020;95:e1854-e1867.
- 11) Rachael McCool, et al. Systematic review and network meta-analysis comparing ocrelizumab with other treatments for relapsing multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders 29 (2019) 55 - 61. .
- 12) Loebel A, et al. Effectiveness of lurasidone vs. quetiapine XR for relapse prevention in schizophrenia: A 12-month, double-blind, noninferiority study. Schizophr Res. 2013;147(1):95-102.
- 13) 포함 조건: EDSS 점수가 3-6.5점인 환자, 다발성 경화증 증상이 나타난지 15년 이상되었으면서 스크리닝에서 EDSS 점수가 5점 이상인 경우 또는 다발성 경화증 증상이 나타난지 10년 미만인면서 스크리닝에서 EDSS 점수가 5점 이하인 환자, 스크리닝에서 IgG index가 상승되었거나 뇌척수액 검사에서 한 개 이상의 IgG oligoclonal band가 검출되는 경우(documented history or the presence at screening of an elevated IgG index or at least one IgG oligoclonal band detected in the cerebrospinal fluid)
- 14) 장애 진행(disability progression): 최소 12주 이상 기저치 EDSS 점수보다 1점 이상 낮아진 경우를 뜻함. 단, 기저 EDSS가 5.5점 보다 큰 경우는 기저치 대비 0.5점 이상 낮아진 경우를 뜻함.
- 15) Jerry S Wolinsky, et al. Long-term follow-up from the ORATORIO trial of ocrelizumab for primary progressive multiple sclerosis: a post-hoc analysis from the ongoing open-label extension of the randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol 2020; 19: 998 - 1009.
- 16) 최소 120주 이상 ORATORIO 임상에 참여한 환자들이 연장 연구에 참여하였음. 본 문헌은 2019.1.7.자 cutoff 결과이며, ORATORIO 연장 연구는 2022.12월에 종료되었음.
- 17) 장애 진행(disability progression): 1) EDSS 기준: 최소 24주 이상 기저치 EDSS 단계보다 1단계

이상 낮아진 경우를 뜻함. 단, 기저 EDSS 단계가 5.5 보다 큰 경우는 기저치 대비 0.5 단계 이상 낮아진 경우, 2) 9HPT 기준: 보드에 있는 9개의 구멍에 9개의 못(peg)을 끼우는 데 걸리는 시간을 측정하는 것으로 기저치 보다 20% 이상 증가한 것이 최소 24주 이상 유지되는 경우, 3) T25FW 기준: 25피트(약 7.6m)를 걷는데 걸리는 시간을 측정하는 것으로 기저치 보다 20% 이상 증가한 것이 최소 24주 이상 유지되는 경우.

18) 대한신경면역학회(), 대한신경과학회()

19) 신청품은 으로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라, 약가협상생략기준금액은 대체약제의 가중평균금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)의 % 금액임.

20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

21) 제약사 제출 예상 사용량(RMS)

	1차 년도	2차 년도	3차 년도
오크레부스주 0.3g	병	병	병

22) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

23) 제약사 제출 예상 사용량(RMS)

	1차 년도	2차 년도	3차 년도
오크레부스주 0.3g	병	병	병

24) 제약사 제출 예상 사용량(PPMS)

	1차 년도	2차 년도	3차 년도
오크레부스주 0.3g	병	병	병

25) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가